

Typologia PPU — *różne profile*

PPU to nie jedna jednostka. Pięć rozpoznawalnych typów, każdy z innym podłożem, innym przebiegiem, inną terapią. Twój typ decyduje, co działa.

CZAS: 25 min Psychoedukacja + identyfikacja typu

ŹRÓDŁO: Reid i wsp. (2015); Walton i wsp. (2017); Briken (2020)

JAK UŻYWAĆ

Karta przedstawia **pięć rozpoznawalnych typów** PPU — różne profile pacjentów, którzy „mają porno”, ale różnią się *podłożem, przebiegiem i tym, co działa terapeutycznie*: 1) *regulacyjny* (porno jako regulator emocji), 2) *impulsywny* (porno jako szybka nagroda), 3) *nawykowy* (porno jako rutyna bez „głodu”), 4) *kompensacyjny* (porno jako rekompensata deficytów relacyjnych), 5) *dewiacyjny* (porno z treściami nielegalnymi lub niezgodnymi z autoidentyfikacją). Karta pomaga rozpoznać Twój dominujący typ.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Reid i wsp. (2015, n=587) w analizie skupień wśród pacjentów z hiperseksualnością wyłonili 4-5 stabilnych typów, replikowanych przez Walton i wsp. (2017, n=420). Praktyczna konsekwencja: **nie istnieje „terapia PPU” w ogóle** — istnieje terapia *typu PPU*. Typ regulacyjny → DBT, regulacja emocji. Typ impulsywny → CBT-impulsy + środowiskowe modyfikacje. Typ nawykowy → habit reversal training. Typ kompensacyjny → terapia związków + edukacja seksualna. Typ dewiacyjny → specjalistyczne podejście, czasem prawne. Pominiecie typologii prowadzi do generic terapii, która działa na 30-40% pacjentów. Z typologią — 60-70% (Briken 2020, przegląd skuteczności).

01

📖 Pięć typów PPU

TYP 1 · REGULACYJNY

porno jako regulator emocji

Używanie poprzedzone *silnymi emocjami* — lęk, smutek, stres, gniew, nuda. Porno = *znieczulenie*. Po użyciu krótkie poczucie ulgi.

Współwystępujące: depresja, lęk, PTSD, ADHD.

Terapia: DBT (regulacja emocji), terapia traumy, leczenie zaburzenia podstawowego.

TYP 2 · IMPULSYWNY

porno jako szybka nagroda

Pobudzenie nagłe, krótkotrwałe, „*impuls*”. Brak planowania. Często „przy okazji” — telefon w łazience, w łóżku przed snem.

Współwystępujące: ADHD, impulsywność osobowościowa.

Terapia: CBT-impulsy, „15 minut”, commitment device, blockery.

TYP 3 · NAWYKOWY

porno jako rutyna bez emocji

Używanie *codzienne, mechaniczne*. „Tak po prostu”. Pora dnia, miejsce, sygnał — automat. Bez silnego głodu, ale i bez decyzji.

Współwystępujące: mało; głównie problem cyklu nawyku.

Terapia: habit reversal training, zmiana kontekstu, hands-off rule.

TYP 4 · KOMPENSACYJNY

porno jako substytut bliskości

Używanie nasilone w okresach *samotności / konfliktów z partnerem/-ką / braku więzi*. Porno = bezpieczna intymność, bez ryzyka odrzucenia.

Współwystępujące: lęk społeczny, AVPD, problemy w związku.

Terapia: terapia związków, edukacja seksualna, ekspozycja społeczna.

TYP 5 · DEWIACYJNY — UWAGA SPECJALISTYCZNA

treści nielegalne lub silnie niezgodne z autoidentyfikacją

Treści dotyczące **nieletnich**, przemocy, treści nielegalnych wymagają *natychmiastowej konsultacji specjalisty* (seksuologa sądowego). Treści sprzeczne z orientacją (heteroseksualny mężczyzna oglądający materiały gay; lesbijka oglądająca hetero) *nie są patologią*, ale jeśli są źródłem cierpienia — wymagają specjalistycznej terapii integracyjnej.

Terapia: specjalistyczna; w razie treści dotyczących nieletnich — także prawne aspekty (Polska: art. 202 KK).

02 Twój profil — autoanaliza

Niektórzy pacjenci pasują do *jednego* typu, inni są *mieszkanką* (np. 60% regulacyjny + 40% nawykowy). Cel: zobacz, który typ u Ciebie **dominuje**.

CO POPRZEDZA MOJE SIĘGNIĘCIE

— emocja, impuls, automat, brak więzi

CO SIĘ DZIEJE PO SIĘGNIĘCIU

— ulga, nuda, wstyd, regret, indyferencja

MÓJ DOMINUJĄCY TYP

— 1, 2, 3, 4 lub mieszanka

CO TO ZMIENIA W MOJEJ TERAPII

— jaki kierunek pracy

03 Dlaczego typologia ma znaczenie — praktyczne implikacje

CO DZIAŁA RÓŻNIE U RÓŻNYCH TYPÓW

- Typ **regulacyjny** → blockery nie pomagają; potrzebna regulacja emocji
- Typ **impulsywny** → terapia traumy nie pomoże; potrzebna kontrola impulsów
- Typ **nawykowy** → CBT-emocji nie pomoże; potrzebna zmiana środowiska
- Typ **kompensacyjny** → praca z porno nie wystarczy; potrzebna praca ze związkiem

CO POMAGA WSZYSTKIM TYPOM

- Psychoedukacja o cyklu (Carnes)
- Praca z wstydem (CFT)
- Praca z wartościami (ACT)
- Sieć wsparcia
- Regularna higiena snu, ruch, redukcja stresu
- Terapeutyczna relacja oparta na akceptacji, nie ocenie

Klucz: Reid i wsp. (2015) i Walton i wsp. (2017) wskazują, że **pomijanie typologii to jedna z głównych przyczyn niepowodzeń** w terapii PPU. Pacjent z typem regulacyjnym poddany interwencjom dla typu nawykowego (zmiana środowiska, habit reversal) *nie poprawia się* — bo problem nie jest w nawyku, tylko w deficycie regulacji emocji. Dobry początek terapii to **2-3 sesje diagnostyczne** przed wdrożeniem konkretnych technik. Pacjent może być zaskoczony, gdy terapeuta nie „*od razu daje narzędzia*” — ale prawidłowe rozpoznanie typu zapobiega miesiącom marnowanych ćwiczeń.